جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فوزية عبد العظيم محمد بخيت

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** السيده زينب **العنوان :** ش السمعية محمد شاهين الجيزة

رقم البطاقة : 28909160100188 **رقم التليفون :** 01141596108 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 16-09-1989 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------)

المقر بما فيه
التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام رنين مغناطيسي على الفقرات الصدرية [12771] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فوزية عبد العظيم محمد بخيت
National ID: 28909160100188

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي MRI of the thoracic spine.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Oncology Center مركز الأورام

وزارة الصحة
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى معهد ناصر
Nasser Institute Hospital

Nuclear Medicine Unit

خطابات أورام

Patient Name: Fawzeia Abdel Azeem Mohamed Date: 19/4/2025

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Referring physician: Prof.

Desired information: *skeletal surveying to detect multiple lesions.*

Technique: Anterior and posterior whole-body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- Abnormal focal enhanced active radiotracer uptake is seen at the left trochanteric femoral bone (likely of metastatic nature) , (for further radiological CT correlation , follow up
- Abnormal heterogenous radiotracer uptake is seen at the spine , likely of spondylo degenerative changes
- Otherwise , no active metastatic osseous lesions could be seen all over the surveyed skeleton .
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

Abnormal active radiotracer uptake s seen at the left trochanteric femoral bone , of metastatic nature , for follow up , ,

Other wise , no active bony lesions could be detected .

Nuclear Medicine Unit

DR . Sherin Mahdy. MD

DR/ Mohamed Emam

١٣٥١ كورنيش النيل - أغاخان - شبرا - القاهرة - ت : ٢٢٠٣٩١٦٤ - ٢٢٠٣٩٣٥٦ فاكس : ٢٢٠٣٩٣٢٦

1351Korniesh El Nile - Aghakhan - Shoubra - Cairo Tel.: 22039164 - 22039356 Fax : 22039 236

Scanned
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

MDT اورام الثدي





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

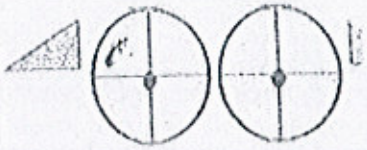
البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : ارزيه عبدالعظيم محمد رخيت Sex: Female
3- Medical number: 83157784
Old Med : 3052-2023

2-ID number 28909160100188

Patient Age : 34 Y



MDT

Family history	Phone	01141596108 01117786838	BMI	REASON OF MDT	POST OPERA
marital status	NRS Score		GROUP B+	Date of MDT	2023-09-1
Co morbidity	Menopausal status	PREMENOPAUSAL			

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	KI67 :
invasive mucinous carcinoma	6/8	7/8	3		10

T	N	M
2(3CM)	0	?/?

Sonomammiography
rt focal asymmetry at lower med. line 6 oclock 3.2 x1.5 cm

PATIENT HISTORY
pop done outside hospital
RT breast WLE+AC
mucinous carcinoma G1
PT2N0
free resected margins
axillary LN 0/8

MDT OUTCOME & PLAN

FOR CTCAP WITH CONTAST, BONE SCAN, IF NON METASTIC FOR TAXOTER CARBOPLATIN HERCEPTIN
THEN PORT
ADJUVANT ZOLADEX FEMARA

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ [illegible]	RADIOLOGY	[illegible]
SURGERY	د/ [illegible]	PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

المنطقة الصدر بعد الوعاء

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Fawzeya Abdel Azeem Mohamed Bekhit	Date : 24/09/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 34 Year(s)
Medical ID: 3052/2023	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Given history of right breast BCS

1. ***Chest:***

- Right axillary scaring is noted with no sizable masses.
- No sizable pulmonary nodules.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Aberrant right subclavian artery (normal anatomical variant).

2. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is average in size with low homogenous texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD is seen in place.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. ***The scanned skeleton:***

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- ***Status post right BCS.***
- ***No definite pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.***

Dr.Mohammed Mohsen, MSc.

Dr. Amr Farouk, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name : Mrs. Fawzya Abd El-Azeem Mohamed
Date : 17-07-2023

Code : R2922193

Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS):

Your category is shaded below in gray.

The rest of the table is only for your information.

Category			
0	Needs further imaging study		
1	Negative (there is nothing to comment on)		
2	Benign Finding		
3	Probably Benign Finding	< 2% malignant risk	short term follow up is recommended
4	Suspicious Abnormality	2- 95% malignant risk	Biopsy should be considered
5	Highly suggestive of Malignancy	> 95% malignant risk	Appropriate Action should be taken
6	Previous Biopsy	Proven Malignancy	

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]